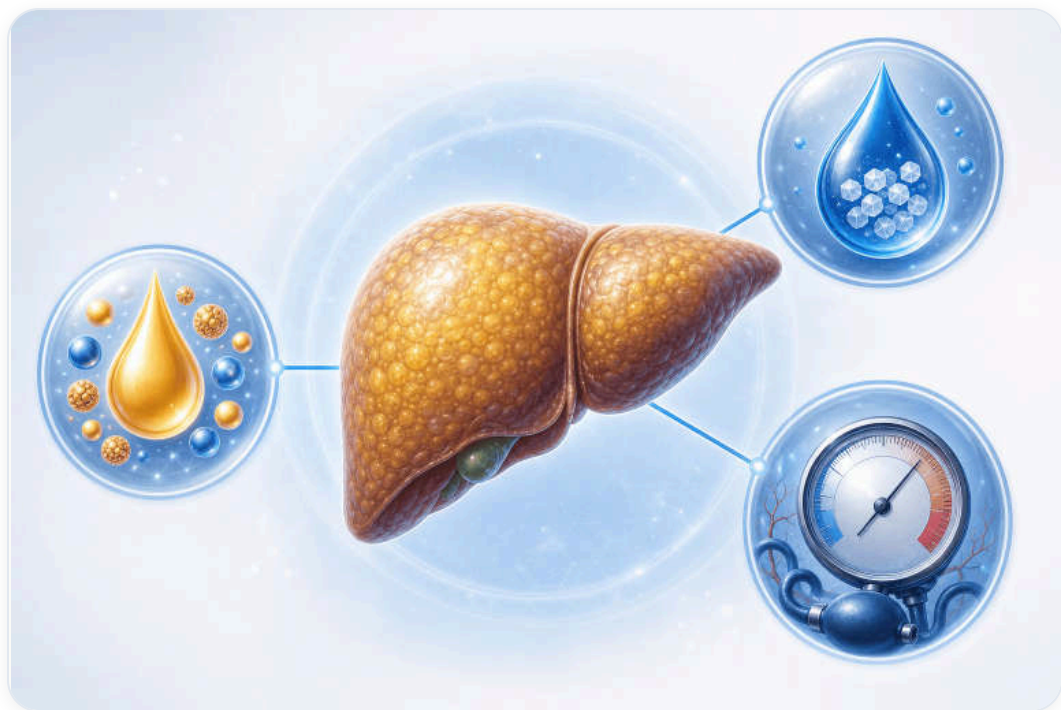


지방간(MASLD), 단순히 "살찐 간"이 아니라 대사질환입니다

MASLD(대사이상 지방간질환) — 당뇨·고혈압·이상지질혈증과 한 묶음인 대사 문제입니다.
가장 위험한 건 간이 아니라 심장이고, 예후를 정하는 건 지방의 양이 아니라 **흉터(섬유화)**
단계입니다. 그리고 되돌릴 수 있습니다.

이름이 바뀐 이유 — NAFLD에서 MASLD로

지방간은 당뇨·고혈압·이상지질혈증과 한 묶음의 대사질환이라는 본질을 담아 이름이 바뀌었습니다



2023년 국제 합의로 '비알코올성 지방간(NAFLD)'이 MASLD(대사이상 지방간질환)로 바뀌었습니다.

바뀐 이유는 두 가지입니다. ① '알코올 아님'·'지방'이라는 낙인을 제거하고, ② 단순히 다른 원인을 배제해서 붙이는 진단이 아니라 '대사 문제가 본질'이라는 점을 이름에 담기 위해서입니다. 질환 자체는 거의 같아서 기존 환자 대부분이 그대로 해당됩니다.

핵심 메시지

"살찐 간"이 아니라 대사질환

당뇨·고혈압·이상지질혈증과 같은 뿌리에서 나오는 한 묶음의 문제입니다.

얼마나 흔한가 · 어떻게 진단하나

간에 지방이 있고 대사위험인자 한 가지만 있어도 진단됩니다 — 그래서 문턱이 낮습니다

3명 중
1명

한국 성인 유병률 약 31%
흔한 대사질환입니다

약 2/3
당뇨 환자

당뇨가 있으면
동반 비율이 더 높습니다

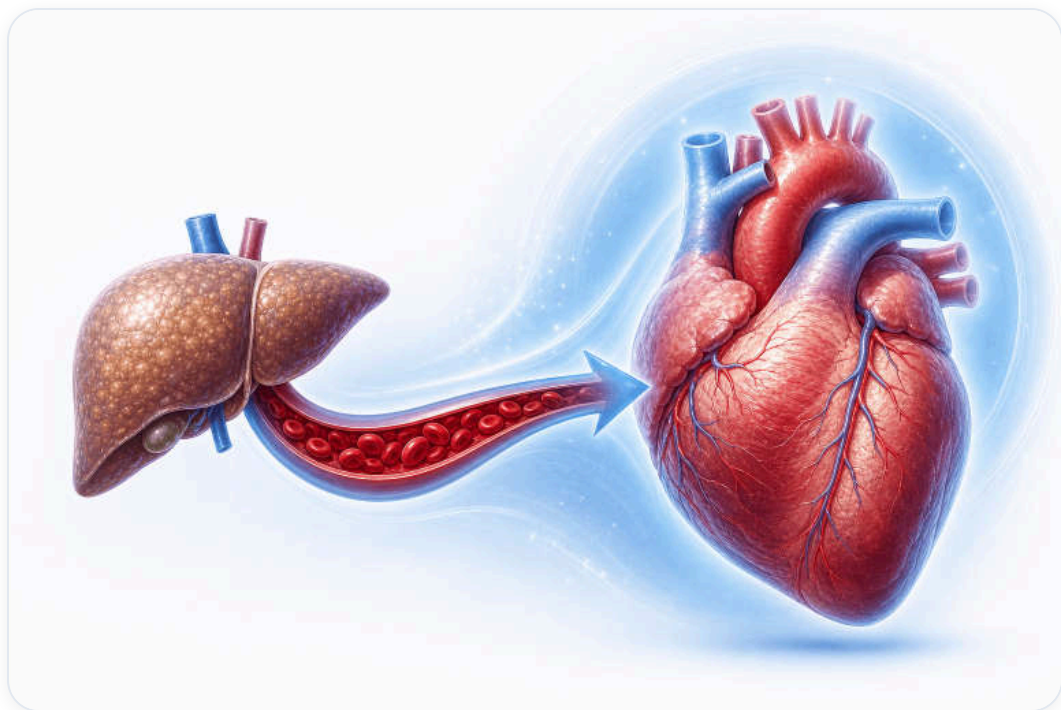
1개
위험인자

간 지방 + 대사위험인자
단 1개만 있어도 진단

진단 기준(한국) — 간에 지방이 있으면서 대사위험인자(CMRF) 중 하나라도 있으면 MASLD입니다. 위험인자에는 **BMI ≥ 23** , 허리둘레 남 $\geq 90\text{cm}$ ·여 $\geq 85\text{cm}$, 그리고 혈당·혈압·중성지방·HDL 이상이 포함됩니다. 기준이 낮아 많은 분이 해당됩니다.

가장 위험한 건 간이 아니라 — 심장입니다

지방간 환자에서 사망 원인 1위는 심혈관질환입니다 — 지방간 진단은 곧 '심혈관 경고등'입니다



일반적인 지방간 환자의 사망 원인은 심혈관질환 > 간외 암 > 간 질환 순서입니다.

즉 지방간을 진단받았다는 것은 심장·혈관에 빨간불이 켜졌다는 신호입니다. 그래서 가장 먼저 챙겨야 할 것은 간 자체보다 혈압·혈당·콜레스테롤·체중 관리입니다. 필요하면 스타틴 같은 약으로 콜레스테롤도 적극적으로 관리합니다.

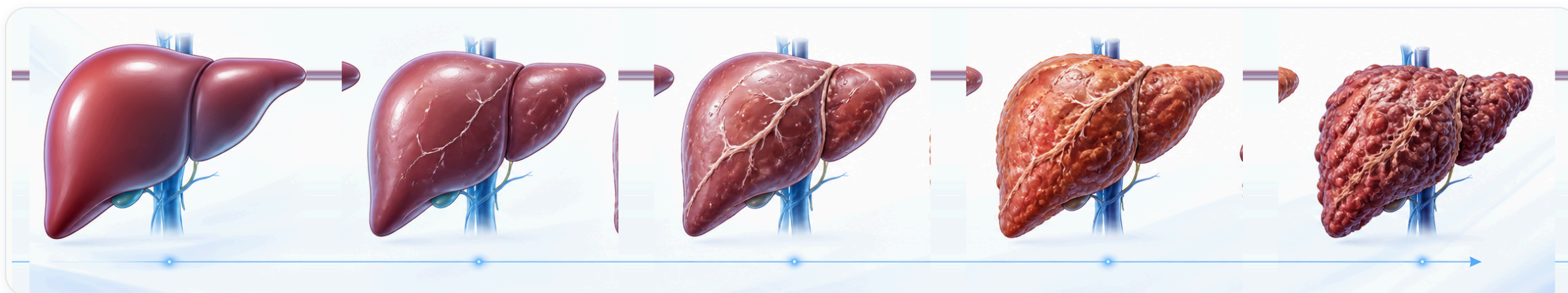
1순위로 관리할 것

혈압 · 혈당 · 콜레스테롤 · 체중

심혈관 위험을 낮추는 것이 지방간 환자에서 가장 중요한 목표입니다.

예후를 정하는 건 — '흉터(섬유화)' 단계입니다

지방의 양이나 염증보다, 간이 얼마나 굳었는지(F0~F4)가 수명을 좌우합니다



F0

흉터 없음
(정상)

F1

경미한
흉터

F2

중등도
흉터

F3

진행성
흉터 (위험↑)

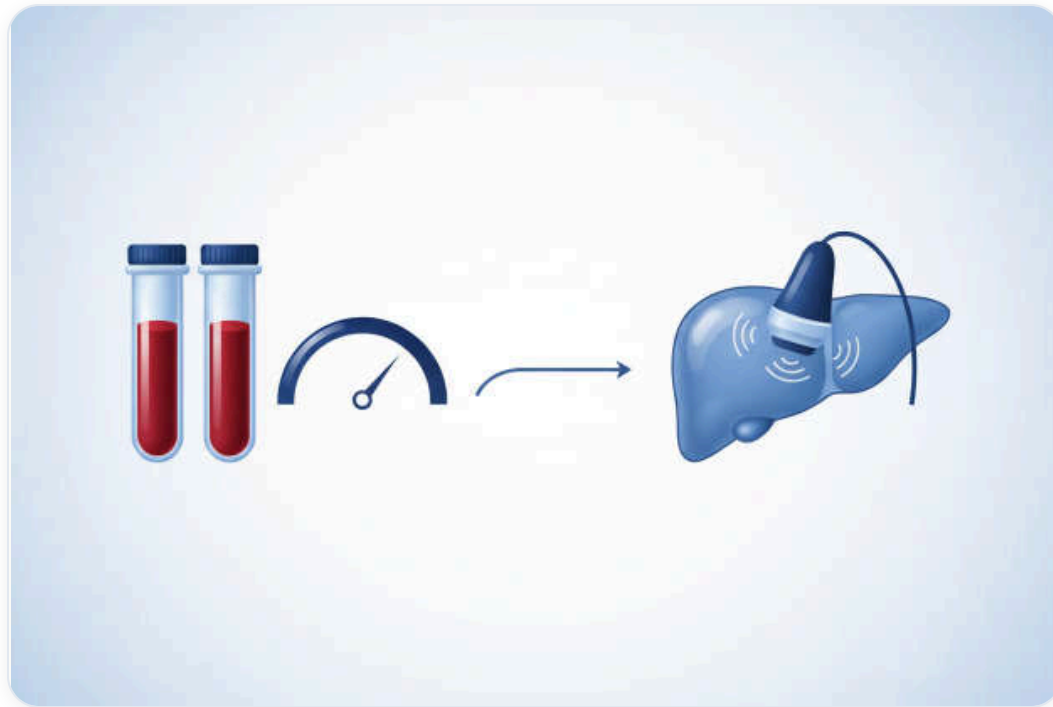
F4

간경변
(위험 급등)

핵심 — F4(간경변)는 F0에 비해 사망 위험이 **6~10배 이상** 높고, 간 합병증은 더 가파르게 늘어납니다. 특히 **F3~F4 단계부터 위험이 급등**합니다. 그래서 "지방이 얼마나 끼었나"보다 "**흉터가 몇 단계인가**"를 확인하는 것이 더 중요합니다.

검사는 간단한 2단계입니다

먼저 피검사(FIB-4)로 위험을 거르고, 필요하면 탄성 초음파(SWE)로 간의 굳기를 잽니다



흉터 위험은 **피검사 → 탄성 초음파** 순서의 2단계로 확인합니다.

1단계 — 피검사

FIB-4

일반 혈액검사 수치로 계산하며 비용이 거의 없습니다. 낮으면 안심, 회색지대거나 높으면 2단계로 갑니다.

2단계 — 탄성 초음파

SWE / 파이버로스캔

간의 굳기(흉터)를 측정합니다. 대략 **9 kPa 미만**이면 안심권, 그 이상이면 추가 평가·전문의 상담이 필요합니다.

추적은 같은 기기로, 검사 전 4시간 공복으로 합니다.

되돌릴 수 있습니다 — 생활습관이 1차 치료

체중을 7~10% 빼고 식사·운동을 바꾸면 지방간염과 흉터가 호전될 수 있습니다

핵심 · 01

체중 7~10% 감량

가장 핵심입니다. **10% 이상** 빼면 지방간염 해소 약 **90%**, 섬유화(흉터) 호전 약 **45%**까지 기대할 수 있습니다.

식사 · 02

지중해식 식사

올리브유·채소·생선·통곡물 위주로 드세요. 당·가당음료·초가공식품·과당은 차단합니다. **가당음료를 주 4회 이상** 마시면 위험이 약 45% 올라갑니다.

운동 · 03

주 150분 운동 + 커피

중강도 유산소 **주 150분**(+근력)을 하면 체중이 안 빠져도 간 지방이 30%가량 줄 수 있습니다. 금기가 없다면 **커피 하루 3잔 이상**도 간경변·섬유화 위험↓와 연관됩니다.

절주 · 04

절주 — 흉터 있으면 금주

술은 줄이는 것이 기본이며, **섬유화가 진행했거나 간경변이면 완전 금주**해야 합니다. 술은 흉터 진행을 빠르게 만듭니다.

음주량에 따른 분류 — MASLD와 MetALD

술을 어느 정도 마시느냐에 따라 분류가 갈리므로, 정확한 음주 문진이 중요합니다

+ MASLD (대사이상 지방간질환)

- + 대사 문제가 주된 원인인 지방간입니다
- + 음주가 적은(기준 이하) 범위에 해당합니다
- + 치료의 중심은 **체중감량·대사조절**입니다
- + 그래도 술은 줄일수록 간에 도움이 됩니다

+ MetALD (대사 + 알코올 영향 구간)

- 대사 문제에 **알코올 영향**이 함께 작용하는 구간
- **경계: 남 하루 30g(소주 약 반병)·여 20g 초과**
- 이 구간부터는 알코올의 영향이 커집니다
- **정확한 음주량 문진이 분류와 치료에 중요합니다**

약은 있나요?

미국은 2종이 승인됐지만 국내는 아직 '지방간염 전용 약'이 미허가입니다 — 핵심은 여전히 체중·대사 관리

구분	대상	설명
미국 승인 — 먹는약 (resmetirom)	흉터 2~3단계 (비경변)	지방간염에 쓰는 경구약으로 미국에서 승인됐습니다. 간경변에는 적응되지 않습니다.
미국 승인 — 주사약 (세마글루티드 2.4mg)	흉터 2~3단계 (비경변)	GLP-1 계열 주사약으로 미국에서 승인됐습니다. 역시 간경변에는 적응되지 않습니다.
국내 현황	미허가	아직 '지방간염 전용 약'은 미허가입니다. 비만·당뇨가 있으면 그 적응증으로 GLP-1 주사 등을 써서 살을 빼 간을 간접적으로 치료합니다.
정리 — 두 약 모두 간경변(간경화)에는 적응되지 않습니다. 따라서 현재 치료의 핵심은 여전히 체중감량과 대사조절입니다.		

간암 검진은 '간경화'부터 시작합니다

흉터 단계에 따라 검진 방법이 달라집니다 — 흉터가 가벼우면 피검사로 위험만 선별합니다



오늘 꼭 기억할 핵심 8가지

지방간(MASLD)을 바르게 이해하고 관리하기 위한 환자 핵심 정리

01 지방간은 "살찐 간"이 아니라 **대사질환**입니다

02 가장 위험한 건 간이 아니라 **심장(심혈관)**입니다

03 예후를 정하는 건 **흉터(섬유화) 단계 F0~F4**입니다

04 검사는 **피검사(FIB-4) → 탄성초음파(SWE)** 2단계

05 **체중 7~10% 감량**이 1차 치료의 핵심입니다

06 지중해식·운동 주150분·커피·절주로 **되돌릴 수 있습니다**

07 국내 전용약은 **미허가** — 핵심은 체중·대사 관리

08 간암 검진은 **간경변부터 6개월마다** 받습니다

지방간 = 심장 경고등, 흉터 단계가 중요하고 — 되돌릴 수 있습니다

"지방간은 단순히 살찐 간이 아니라 대사질환이에요. 체중을 7~10% 빼고 혈압·혈당·콜레스테롤을 함께 관리하면 흉터도 좋아질 수 있어요. 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요."

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광고중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요